

Titre :

Impact de la dapagliflozine sur la fonction cardiaque et la gestion glycémique chez les patients avec comorbidité diabète et insuffisance cardiaque : série de 50 cas

Introduction :

Les inhibiteurs du SGLT2, notamment la dapagliflozine, ont montré des bénéfices cardiorénaux chez les patients diabétiques et non-diabétiques souffrant d'insuffisance cardiaque. Cependant, les mécanismes d'action et le profil d'efficacité de la dapagliflozine chez les patients atteints de cardiopathie et de diabète nécessitent une investigation clinique approfondie. Cette étude de série de cas vise à évaluer l'impact de la dapagliflozine sur la fonction ventriculaire, le contrôle glycémique, et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque.

Méthodes :

Une cohorte de 50 patients, âgés en moyenne de 65 ± 8 ans, présentant une insuffisance cardiaque (IC) avec fraction d'éjection réduite (HfrEF) et un diabète de type 2 mal contrôlé, a été suivie sur une période de 12 mois après initiation de la dapagliflozine à 10 mg/jour. Les paramètres de suivi incluaient la FEVG (échocardiographie), le taux d'HbA1c, la classification NYHA, et les hospitalisations pour décompensation cardiaque. Les analyses statistiques ont porté sur les variations moyennes de la FEVG et de l'HbA1c, ainsi que la comparaison des hospitalisations avant et après traitement.

Résultats :

À 12 mois, une amélioration statistiquement significative de la FEVG a été observée, passant de 35 ± 6 % à 42 ± 5 % ($p < 0,01$). Le taux moyen d'HbA1c a diminué de $8,5 \pm 1,2$ % à $7,4 \pm 1,0$ % ($p < 0,05$), et 68 % des patients ont enregistré une amélioration d'au moins une classe NYHA. Les hospitalisations pour IC ont été réduites de 35 % par rapport aux 12 mois précédant l'initiation de la dapagliflozine, indiquant une stabilisation clinique avec réduction des événements aigus.

Conclusion :

La dapagliflozine démontre un effet bénéfique robuste chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque et de diabète, avec des améliorations notables de la fonction systolique et du contrôle glycémique, associées à une diminution significative des

hospitalisations pour décompensation. Ces observations renforcent la place des iSGLT2 comme stratégie thérapeutique intégrée dans la prise en charge de l'IC avec comorbidité diabétique, et mettent en exergue la nécessité de recherches complémentaires pour élucider les mécanismes cardiorénaux sous-jacents.

Références :

1. McMurray, J. J., Solomon, S. D., Inzucchi, S. E., et al. (2019). Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction. *New England Journal of Medicine*, 381(21), 1995-2008.
2. Packer, M., Anker, S. D., Butler, J., et al. (2020). Cardiovascular and renal outcomes with empagliflozin in heart failure. *New England Journal of Medicine*, 383(15), 1413-1424.